Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel

Rua Onésimo Laureano, 75 - Bairro: Centro - CEP: 97304032 - Fone: 559997-4663 - Email: frsaogabr2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001510-39.2022.8.21.0031/RS

AUTOR: DAIANE DA SILVA DE LIMA

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

DAIANE DA SILVA DE LIMA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE - PREV**, postulando a condenação da parte ré ao fornecimento do medicamento DALINVI (daratumumab 1.800 mg). Aduziu, em síntese, que é segurada do IPE-SAÚDE e que possui mieloma múltiplo (CID 10 C90.0). Disse que necessita fazer uso da medicação DALINVI (daratumumab 1.800 mg) em decorrência da doença que lhe acomete, em número total de 24 (vinte e quatro) ampolas, a serem aplicadas nos ciclos descritos no laudo médico. Afirmou que solicitou o fornecimento do medicamento na via administrativa, porém o pedido foi negado. Alegou que o fornecimento do medicamento é obrigação do plano de saúde, independentemente de não constar em seus protocolos. Discorreu sobre o direito à saúde, citando precedentes jurisprudenciais. Pugnou pelo benefício da gratuidade da justiça. Formulou pedido de tutela de urgência. Requereu a procedência do pedido, para condenar a parte ré ao fornecimento do medicamento DALINVI (daratumumab 1.800 mg), na quantidade de 24 (vinte e quatro) ampolas. Acostou documentos (evento 1, DOC1).

Intimada a parte autora para juntar aos autos laudo médico fundamentado (evento 3, DOC1).

A parte autora apresentou emenda à petição inicial (evento 6, DOC1).

Deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, recebida a petição inicial e deferido o pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento DALINVI (Daratumumabe) 1800mg, observado-se a Denominação Comum Brasileira (DCB), assim como a aquisição do medicamento genérico, em igualdade de preço, se houver, sob pena do bloqueio do valor corresponde ao fármaco (evento 8, DOC1).

Citada (Evento 21), a parte ré ofereceu contestação (evento 28, DOC1), aduzindo, em síntese, que o fornecimento do medicamento postulado não faz parte das recomendações de oncologia do IPE-SAÚDE e, por essa razão, não foi autorizado administrativamente. Discorreu sobre a cobertura do plano de saúde, por ser de natureza pública, não se lhe aplicando a legislação referente aos direitos do consumidor ou dos demais planos de saúde. Refutou a pretensão da parte autora. Postulou a improcedência do pedido da parte autora. Acostou documentos.

Irresignada com a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, a parte ré interpôs agravo de instrumento (Evento 29 e Evento 30), ao qual foi negado provimento (evento 19, DOC1).

Houve réplica (evento 34, DOC1).

A autora noticiou ter concluído o tratamento (evento 37, DOC1).

Intimada a parte ré acerca da informação do requerente (evento 38, DOC1), não houve manifestação (Evento 39).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito tramitou regularmente com a observância de todas as formalidades legais, estando isento de vícios.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista que as partes não manifestaram interesse na produção de provas.

Não foram aventadas pelas partes, assim como não verifico, de ofício, nenhuma questão preliminar, prejudicial ou nulidade a ser decretada.

Desde já, ressalto que, embora a parte autora tenha informado que concluiu o tratamento médico (evento 37, DOC1), o fármaco postulado somente foi concedido após o deferimento do pedido de tutela de urgência (evento 8, DOC1), de modo que o pleito da parte autora deve ser analisado para conferir tons de definitividade ao requerimento inicial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora sustentou que é segurada do IPE-SAÚDE e que possui mieloma múltiplo (CID 10 C90.0), razão pela qual necessita da concessão do medicamento DALINVI (daratumumab 1.800 mg), em número total de 24 (vinte e quatro) ampolas.

A parte ré, por sua vez, defendeu que o fornecimento do medicamento postulado não faz parte das recomendações de oncologia do IPE-SAÚDE e, por essa razão, não foi autorizado administrativamente.

O pedido da parte autora merece prosperar.

De acordo com o art. 4° da Lei Complementar nº 15.145/2018, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-SAÚDE – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

Para mais disso, o art. 4°, §1°, da Lei Complementar nº 15.145/2018, ficam excluídos da cobertura do IPE-SAÚDE os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

No caso em análise, os documentos anexados ao caderno processual demonstram que a parte autora foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID 10 C90.0), necessitando fazer uso da medicação DALINVI (daratumumab 1.800 mg) (evento 6, DOC3).

De acordo com a carta de indeferimento da autarquia demandada, o medicamento postulado não foi concedido, uma vez que não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia do IPE-SAÚDE (evento 1, DOC5).

O cerne dos autos cinge-se à responsabilidade da autarquia demandada para o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora, tendo em vista a ausência de previsão do fármaco nas recomendações de oncologia do IPE-SAÚDE.

A Lei Complementar nº 15.145/2018, que entrou em vigor em 06/04/2018, dispõe sobre o IPE-SAÚDE e prevê que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde previstos em tabelas próprias, excluindo-se, contudo, procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais nela não previstos, conforme previsto no art. 4°, *caput,* e §1°.

Já o art. 8° da Resolução nº 21/1979 do IPERGS, que regulamenta a Assistência Médico-Hospitalar do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), inclui, no plano de assistência médica, consoante expressa previsão em seu art. 8°, as seguintes especialidades:

> *"anestesiologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geral, ginecologia, hematologia e hemoterapia, imunologia (alergia), medicina nuclear, nefrologia, obstetrícia, oftalmologia, oncologia, otorrinolaringologia, patologia clínica e cirurgia, pediatria, plástica reparadora, proctologia, psiquiatria, radiologia, radioterapia, reumatologia, tisiopneomologia, torácica, traumatologia e urologia."*

Outrossim, o art. 2º da Resolução n° 21/1979 do IPERGS regulamenta o plano de assistência médica, dispondo que o Plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes cobrirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento da moléstia.

Desse modo, tendo em vista o disposto na Resolução nº 21/1979 do IPERGS quanto ao Plano de Assistência Médica, o procedimento ao qual deve ser submetido a paciente está assegurado, conforme se verifica no art. 8º do aludido ato normativo, no tocante às especialidades cobertas pelo plano do demandado, dentre as quais está a angiologia, hematologia e oncologia.

Da mesma forma, o art. 9º da Resolução nº 21/1979 do IPERGS disciplina que a assistência médico-hospitalar abrangerá os serviços de emergências, consultas médicas, serviços complementares, tratamento ambulatorial e tratamento médico, dentre outros serviços.

Ademais, o critério que define a cobertura dos serviços de tratamento hospitalar oferecidos pelo Plano de Assistência Médica é o da exclusão expressa, encontrando-se explícita vedação apenas aos atendimentos psiquiátricos e cirurgias plásticas estéticas ou não éticas, conforme se infere dos arts. 41 e 42 da Resolução nº 21/1979 do IPERGS, de modo que a autarquia estadual deve fornecer o tratamento postulado pela parte autora, notadamente diante da ausência de expressa exclusão de cobertura do tratamento descrito na petição inicial.

Além disso, a ausência de previsão expressa nas tabelas de cobertura do IPE-SAÚDE não pode, por si só, servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, sob pena de violação do direito à saúde previsto no art. 196 da CRFB/88.

No ponto, o Tribunal de Justiça do Estado afirmou no julgamento do agravo de instrumento interposto pela autarquia demandada que a ausência de previsão nas tabelas de cobertura do IPE-SAÚDE não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado pela parte autora, uma vez que o médico assistente possui as melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o direito constitucional à saúde ser limitado a uma simples tabela ou protocolo (Agravo de Instrumento n° 5096702-44.2022.8.21.7000, evento 19, DOC1).

A propósito, colaciono o seguinte excerto do acórdão proferido pelo TJ/RS no Agravo de Instrumento n° 5096702-44.2022.8.21.7000 (evento 19, DOC1)

(...)

Todavia, em que pese as disposições da nova lei, entendo que a ausência de previsão nas tabelas de cobertura do Ipê-Saúde não deve servir enquanto obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Destaco que o médico da parte autora, por acompanhar o paciente desde o início de seu problema, é quem - ao menos em tese - tem as melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, não podendo o direito constitucional à saúde ser limitado a uma simples tabela ou protocolo.

É importante também lembrar que a limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao seu paciente é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, Anexo, Capítulo I, XVI), conforme se segue:

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente."

Sobre a matéria em análise, esta Corte tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão em tabela do Ipê-Saúde não é o suficiente para negativa de autorização de tratamento indicado por médico credenciado, conforme se verifica pelos procedentes a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ***TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BRENTUXIMABE VENDOTINA. NEGATIVA DO IPE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. CÂNCER LINFOMA HODGKIN. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA MEDICAÇÃO POSTULADA, DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE FÁRMACO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE O SEGURADO****. A concessão da tutela antecipatória de urgência pressupõe a concorrência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário. "Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia. O Protocolo Oncológico aplicado pelo IPERGS se reporta ao ano de 2010, passados, pois, mais de sete anos, não tendo as orientações lá contidas pretensão de serem completas ou definitivas, sendo a atualização oncológica um fenômeno continuado que requer revisões frequentes." ("ut" trecho da ementa do Acórdão do Agravo de Instrumento Nº 70078464625). Possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência requerida na inicial, para determinar à Autarquia estadual a dispensação do fármaco postulado pelo segurado, diante da comprovação dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52475377820218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-03-2022)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. ***TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO – HEPATOCARCINOMA - CID 10: C 22. PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DENOMINADOS AVASTIN (BEVACIZUMABE) 400/MG E TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) 1200/MG. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA NA ORIGEM.*** *MANUTENÇÃO. 1. Hipótese em que o demandante é segurado do IPERGS e foi diagnosticado com HEPATOCARCINOMA (câncer no fígado), CID 10: C22, necessitando de medicações para controle da doença, sendo concedida, na origem, tutela de urgência determinando o fornecimento dos fármacos cuja dispensação fora negada na via administrativa. 2. Não há como ser considerada legítima a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, oncologia), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPE-SAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de cobertura. Precedentes deste TJ/RS. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51966794320218217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 23-02-2022)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ***IPÊ-SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. A DEMANDA TRATA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA.*** *A NEGATIVA DO IPÊ SAÚDE NA VIA ADMINISTRATIVA SE DEU SOB O FUNDAMENTO DE QUE O FÁRMACO NÃO ESTÁ PREVISTO NAS ATUAIS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM ONCOLOGIA DO IPÊ SAÚDE. A LEI COMPLEMENTAR Nº 15.145/2018, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPE-SAÚDE), PREVÊ A COBERTURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, ASSIM COMO OS ATOS NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO DEVIDOS AOS USUÁRIOS. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PROTOCOLO ONCOLÓGICO, NÃO DEVE SERVIR DE OBSTÁCULO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A PREVISÃO DA PATOLOGIA NO PROTOCOLO, BEM COMO A IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50322748720218217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 22-04-2021)*

Grifados.

Inclusive, válido ressaltar que, de acordo com as Recomendações Técnicas em Oncologia do próprio Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul – as orientações ali constantes "é, essencialmente, uma relação de protocolos e recomendações cientificamente reconhecidas. Não tem como objetivo interferir na conduta médica ou autonomia profissional. Casos excepcionais e não previstos neste momento poderão ser encaminhados para discussão".

No mesmo sentido são as Diretrizes de Cobertura dos Tratamentos Oncológicos do Sistema IPE-Saúde, instituídas pela Instrução Normativa IPE-Saúde n° 024, de 27 de abril de 2021.

Destarte, presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, há que se relevar que no atual momento a opção deve-se dar pelo mal menor, sendo este o dispêndio financeiro da Autarquia para o fornecimento do tratamento necessário. O agravamento do quadro clínico da parte agravante, sem dúvidas, é o mal maior.

(...)

Não fosse isso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do AgInt no REsp n. 1.776.448/SP de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

No mesmo sentido da Corte Superior, cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DARATUMUMABE (DALINVI®) E NAUSEDRON. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS EM ONCOLOGIA. RECUSA ILEGAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. ***O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP)****. 2. No caso dos autos, opõe-se ré ao fornecimento do medicamento postulado pela parte autora sob o fundamento de que não há previsão de cobertura em suas atuais Recomendações Técnicas em Oncologia. Ocorre que, da análise dos autos, não se vislumbra a existência de alternativa terapêutica eficaz à condição que acomete a demandante.* ***Desta feita, devidamente comprovada a necessidade dos medicamentos DARATUMUMABE (DALINVI®) e NAUSEDRON para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora, impõe-se a condenação do IPE-SAÚDE ao seu fornecimento, ainda que ausente previsão expressa nas tabelas da autarquia previdenciária, em atenção ao entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Juízo de procedência do pedido mantido em remessa necessária****. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §8º, DO CPC. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nas causas referentes à saúde em que vencida a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, uma vez que nestas ações, em que se busca preservar, ao fim e ao cabo, a vida, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte demandante. Tema 1255 ainda não julgado pelo e. STF. 2. Viável que a verba honorária seja majorada para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a jurisprudência desta Corte. 3. Apelo parcialmente provido. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação/Remessa Necessária, Nº 50262404720228210021, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 14-10-2023) Grifei.*

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO DE CADEIAS LEVES (CID-10 C90.0). DARATUMUMABE (DALINVI) 1200 MG EV. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DO IPE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS. DESCABE AO PLANO DE SAÚDE PÚBLICO SELECIONAR O TIPO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DO SEGURADO. ***A Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), prevê a cobertura de atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento da patologia de que padece o beneficiário. "Em que pese a edição da Lei Complementar nº. 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº. 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão no Protocolo Oncológico 2010 e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurada da autarquia****. O Protocolo Oncológico aplicado pelo IPERGS se reporta ao ano de 2010, passados, pois, mais de sete anos, não tendo as orientações lá contidas pretensão de serem completas ou definitivas, sendo a atualização oncológica um fenômeno continuado que requer revisões frequentes." ("ut" trecho da ementa do Acórdão do Agravo de Instrumento Nº 70078464625). No caso concreto, restou demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento postulado ao adequado tratamento da patologia que acomete o segurado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADOR PARTICULAR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e parâmetro adotado por esta Câmara em situações similares. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70085469880, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-02-2022) Grifei.*

Portanto, o pedido formulado pela parte autora merece prosperar, para condenar a autarquia demandada ao fornecimento do medicamento DALINVI (daratumumab 1.800 mg), em número total de 24 (vinte e quatro) ampolas, para tratamento de mieloma múltiplo (CID 10 C90.0), confirmando a tutela de urgência deferida no evento 8, DOC1.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por **DAIANE DA SILVA DE LIMA** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-SAÚDE**, para **CONDENAR** a parte ré a fornecer à parte autora o fármaco **DALINVI (Daratumumabe) 1800mg**, ou os meios necessários para a sua aquisição, **confirmando a tutela de urgência concedida no evento 8, DOC1**.

Retifique-se o polo passivo no Sistema Eproc, para constar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Rio Grande do Sul – IPE-SAÚDE, conforme requerido no evento 28, DOC1, fl. 02.

Em razão da sucumbência, condeno a autarquia demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, dado o inestimável proveito econômico das ações de saúde.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser acrescidos de correção monetária, a contar da data de arbitramento, e de juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos moldes do art. 85, §16, do Código de Processo Civil, uma vez que atribuídos em quantia certa.

Isento o IPE-SAÚDE do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I, da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014-CGJ).

Caso a parte vencedora tenha antecipado taxa única e despesas, o ente público deverá reembolsar estes valores da seguinte forma (Lei n° 14.634/2014, art. 5º, parágrafo único, parte final):

a) com correção pelo IPCA-E (admitida a deflação, preservado o valor nominal, conforme o Tema n° 678 do STJ) a contar da data de cada desembolso;

b) com juros moratórios à taxa aplicada à caderneta de poupança (art. 12, inc. II, da Lei Federal n° 8.177/1991), a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita à remessa necessária, na forma do art. 496, §3°, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa não supera o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos nacionais.

Na hipótese de interposição de recursos voluntários pelas partes, cumprirá ao Cartório intimar a parte contrária para contrarrazões e, imediatamente após – apresentadas ou não as contrarrazões –, proceder à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, independentemente de conclusão.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CCalc para apuração de eventuais custas finais e despesas processuais.

Havendo custas e despesas processuais pendentes, encaminhe-se a guia à Central de Cobranças (CC). Saliento que, conforme o Ato nº 072/2022-P da Presidência, a cobrança das custas finais do processo será integralmente realizada pelo Departamento de Receita-Serviço de Cobrança, do Tribunal de Justiça, cabendo ao Cartório a comunicação ao aludido órgão acerca da pendência de custas, mediante remessa da guia à Central de Cobranças (CC), na forma disponibilizada no sistema, caso a parte sucumbente não seja beneficiária da gratuidade judiciária.

Sentença publicada e registrada neste sistema.

Intimações eletrônicas expedidas no ato.

Oportunamente, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA SILVEIRA, Juíza Substituta**, em 04/08/2025, às 16:04:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10083134037v37** e o código CRC **17e88e51**.